Códigos de exames

Com que código cada convênio fatura cada exame

APASBS — Sistema de Gestão em Saúde
APAS Baixada Santista · Hospital Santo Expedito
Atualizado em 10/09/2026

Sumário

1. Para que serve

O de/para que vivia na parede

2. Cadastrar e consultar

Vários códigos por exame, com a Tabela 22

3. O mesmo código em outro convênio

A coluna que o papel não tinha

4. Perguntas rápidas

1 Para que serve

O mesmo exame tem um código diferente em cada convênio. Pior: às vezes tem **mais de um código no mesmo convênio**, porque a operadora fatura o exame em vários lançamentos.

Esse de/para costuma viver numa folha impressa colada na parede, ou na cabeça de quem faz o faturamento há anos. Quando essa pessoa falta, ninguém sabe.



Quantas combinações existem, quantos códigos ao todo e o que ficou pela metade.

Como a informação é organizada

Cada registro é a combinação de **um convênio** com **um exame**, e dentro dele ficam os códigos daquele par:

- **Convênio** — a mesma lista que as Autorizações usam. Um convênio cadastrado num lugar aparece no outro.
- **Descrição do exame** — como o convênio chama, e não como a casa chama. É proposital: a tabela da operadora diz *"ECO TRANSTORÁCICO C/ DOPPLER"* onde nós dizemos *"Ecocardiograma"*, e é o nome dela que aparece na guia.
- **Códigos** — um ou vários, cada um com sua descrição.

> **Um registro por convênio + exame.** Se "Bluemed / ECO TRANSTORÁCICO" já existe, o sistema recusa criar um segundo e oferece abrir o que há para acrescentar o código ali. A mesma informação em duas linhas é a origem de metade das divergências de cadastro: uma é atualizada, a outra não, e ninguém sabe qual vale.

Sem código ainda

Dá para cadastrar o exame antes de ter os códigos em mãos — acontece quando a tabela do convênio ainda não chegou. Esses registros ficam contados no cartão **Sem código**, e o número leva direto para a lista deles, para o cadastro pela metade não ser esquecido.

2 Cadastrar e consultar

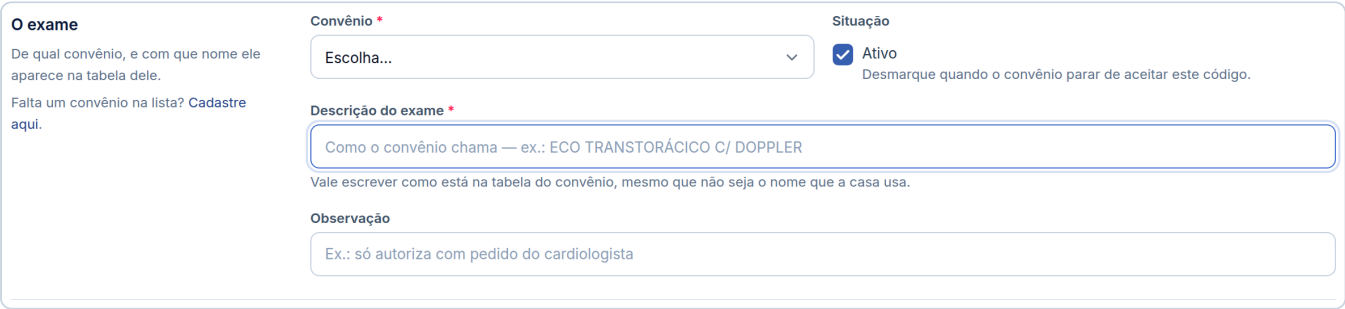
Em **Ambulatório › Códigos de exames**. A lista vem agrupada por convênio, com o nome dele como faixa cinza.



Os códigos de cada exame ficam à vista, sem precisar abrir.

Cadastrar um exame

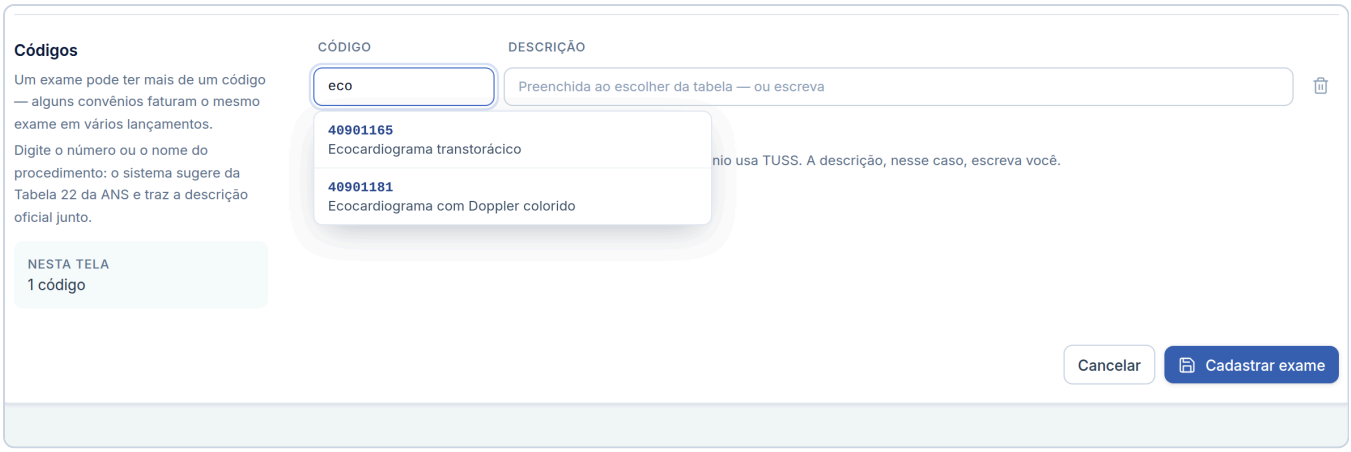
Novo exame. Escolha o convênio e escreva a descrição como está na tabela dele.



Convênio e descrição; a observação guarda a regra que não cabe no nome.

Os códigos

Embaixo ficam as linhas de código — comece digitando **o número ou o nome do procedimento**. O sistema procura na Tabela 22 da ANS, que já vem carregada no APASBS, e mostra o que encontrar:



Escolher uma sugestão preenche a descrição oficial junto.

Não é preciso clicar na sugestão. Quem já sabe o código de cor digita os oito dígitos e segue para o campo seguinte: se o número for exatamente um código da Tabela 22, **a descrição entra sozinha**. Clicar na lista continua valendo — serve para quando se busca pelo nome do procedimento e não se sabe o número.

`Acrescentar um código` abre outra linha. A lixeira no fim da linha tira uma. Não precisa apagar a linha vazia do fim antes de salvar — o sistema a descarta sozinho. Cada linha busca por conta própria: preencher três seguidas, uma atrás da outra, não atrapalha nenhuma delas.

> **O código não precisa ser TUSS.** Se o convênio usa código próprio, digite assim mesmo: nenhuma sugestão vai aparecer, e é só escrever a descrição você. Travar isso impediria cadastrar o que existe de verdade.

> **O que você escreve à mão fica.** A descrição só é preenchida sozinha quando está vazia ou quando foi o próprio sistema que a pôs ali. Se você escreveu o nome que a casa usa, ele permanece, mesmo que o código seja da Tabela 22. E se depois você trocar o código, a descrição que veio da tabela acompanha a troca — a que foi escrita à mão, não.

Por que a descrição fica guardada

Quando você escolhe da tabela, a descrição oficial é **copiada** para o registro em vez de ficar apontando para a tabela. A ANS revisa a Tabela 22 de tempos em tempos; o que foi combinado com o convênio precisa continuar dizendo o que dizia quando foi combinado.

Consultar

A busca procura ao mesmo tempo na **descrição do exame**, no **número do código** e na **descrição do código**. Ou seja: dá para chegar pelo nome do exame, pelo código que veio na glosa ou pelo nome oficial do procedimento.

Ao lado ficam o filtro por convênio e duas caixas: **Só os ativos** e **Só os sem código**.

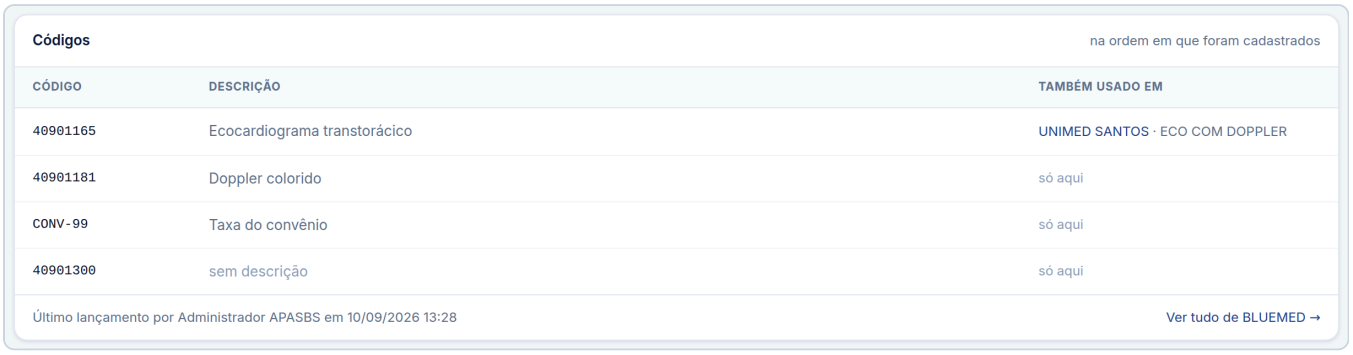
Quando o convênio muda o código

Edite o exame e troque o código. Se o código antigo não vale mais mas você quer manter o registro, desmarque **Ativo** — ele sai das buscas do dia a dia e continua no cadastro.

> **Excluir apaga os códigos junto.** Excluir o exame remove todos os códigos dele, e isso não pode ser desfeito. Para tirar de circulação sem perder o histórico, desative em vez de excluir.

3 O mesmo código em outro convênio

Clicar na descrição abre o exame por dentro, com uma coluna que o papel na parede nunca teve: **Também usado em**.



Cada código diz em que outros convênios ele aparece.

Para cada código, o sistema procura o mesmo número no cadastro inteiro e mostra onde mais ele está — com link direto. É a resposta para a pergunta que aparece no meio de uma glosa: *"a Unimed paga esse exame com o mesmo código que a Bluemed?"*

Quando o código só existe naquele registro, a coluna diz **só aqui**. Não é problema — é só a informação de que não há paralelo.

> **Dá para chegar pelo caminho inverso.** Busque pelo número do código na lista: aparecem todos os convênios que o usam, cada um com a descrição que dá a ele.

4 Perguntas rápidas

O mesmo exame tem dois códigos. Faço dois cadastros?

Não. É um cadastro só, com duas linhas de código dentro. A trava de duplicidade existe justamente para isso: se você tentar, ela oferece abrir o que já existe.

Cadastrei a descrição errada e o sistema não deixa corrigir criando outro.

Não crie outro: abra o que existe e edite a descrição. O registro é o mesmo, com os códigos preservados.

Dois convênios chamam o exame do mesmo jeito.

Sem problema. A trava é por convênio + descrição — a mesma descrição em convênios diferentes são dois registros legítimos, e é exatamente para isso que o módulo serve.

Digitei o código e a descrição não apareceu.

Confira o número: a descrição só entra sozinha quando o que está no campo é *exatamente* um código da Tabela 22 — um dígito a mais ou a menos e não há correspondência. Se o número estiver certo e mesmo assim nada vier, é código que não é TUSS: escreva a descrição você mesmo. E se você salvar com a descrição vazia, o sistema ainda faz uma última busca na hora de gravar e preenche o que encontrar.

Posso apagar só um código, sem apagar o exame?

Pode: edite o exame e clique na lixeira daquela linha. Só o que estiver na tela ao salvar é gravado.

De onde vêm os convênios?

Do mesmo cadastro das Autorizações, em **Ambulatório › Autorizações › Convênios**. Um convênio incluído lá aparece aqui na hora — são a mesma lista de propósito, para os dois módulos nunca discordarem sobre o nome de uma operadora.

Quem cadastrou ou mudou um código?

O rodapé da tela do exame mostra quem fez o último lançamento e quando. O histórico completo está em **Configurações › Auditoria**.